TEMA 14 · Educación para la salud y autocuidado. Salud pública, indicadores de salud y priorización

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Educación para la salud (teorías, metodología, técnicas, autocuidado, programas, autoayuda y agentes de salud) · Bloque B: Salud pública, conceptos de salud, indicadores, problemas de salud, priorización, determinantes y PBE

A1. Concepto y marco legal de la EpS

- Proceso **planificado, sistemático y participativo** que facilita **cambios voluntarios** de conducta (nunca impuestos), mejora la **alfabetización en salud** y promueve la corresponsabilidad. No es solo informar: la información es unidireccional; la educación es **bidireccional**, se adapta al educando y se evalúa.
- **Promoción de la salud** (Ottawa, 1986) es el concepto amplio (actúa sobre los determinantes); la EpS es su herramienta operativa. Se usa en los tres niveles de prevención (primaria: estilos de vida; secundaria: adherencia a cribados; terciaria: autocuidado, p. ej., pie diabético).
- Tres niveles metodológicos: **individual, grupal y comunitario**.

Norma	Clave
Ley 14/1986, General de Sanidad	**Art. 6**: actuaciones orientadas a la educación sanitaria; **art. 18**: acción prioritaria
Ley 16/2003	EpS como prestación de salud pública en la cartera común
Ley 33/2011	**"Salud en todas las políticas"** y alfabetización en salud
Ley 4/1994 y Decreto 148/2002	Competencias de EpS de la AP del SMS

A2. Teorías y modelos

Modelo	Autor	Clave
Creencias en salud	**Rosenstock**	Susceptibilidad y gravedad percibidas (amenaza), beneficios y barreras
Acción razonada / conducta planificada	**Fishbein y Ajzen**	La **intención**: actitud, norma subjetiva y control conductual percibido
Teoría social cognitiva	**Bandura**	**Autoeficacia**; aprendizaje **vicario** u observacional (modelado)
Transteórico	**Prochaska y DiClemente**	Precontemplación → contemplación → preparación → acción → **mantenimiento (> 6 meses)**
Autocuidado	**Orem**	Agencia y déficit de autocuidado; sistema de **apoyo-educación**
Promoción de la salud	**Nola Pender**	Autoeficacia y afecto ligados a la conducta
Aprendizaje significativo	**Ausubel**	Conectar lo nuevo con los **conocimientos previos**
Andragogía	**Knowles**	El adulto necesita saber por qué, aporta experiencia, se orienta a problemas reales
Ecológico	Bronfenbrenner	Niveles individual, interpersonal, organizacional, comunitario y político

- **Fuentes de autoeficacia (Bandura)**: **experiencias de dominio** (la más potente: éxitos tempranos), experiencias vicarias, persuasión verbal y estados fisiológicos y emocionales.
- **Precontemplación**: el paciente no ve el problema. **Contemplación**: ambivalencia.
- **Orem**: sistemas de enfermería **totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo-educación** (el de la EpS).

A3. Metodología y técnicas

	Individual	Grupal	Comunitaria
Personalización	Máxima	Media	Baja

	Individual	Grupal	Comunitaria
Alcance	1 a 1	**6-10 personas**	Población
Fortaleza	Relación terapéutica, autoeficacia	**Apoyo mutuo, aprendizaje vicario**	Actúa sobre los determinantes sociales
Técnicas	Teach-back, entrevista motivacional	Dinámicas, role-playing	**Mapeo de activos**, intersectorialidad, **PACAP**

- **Objetivos SMART**: eSpecífico, **Medible** (cifra), Alcanzable, Relevante y **Temporalizado** (plazo). "Comer mejor" no es SMART; "caminar 30 minutos 5 días por semana desde el lunes", sí.
- **Teach-back**: el paciente explica con sus palabras; **evalúa la claridad del profesional**, no la capacidad del paciente; si hay errores, se **reformula** (no se repite igual). **Chunking and checking**: bloques breves y comprobación.
- **Consejo breve (5 aes)**: **Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar, Asegurar** el seguimiento.
- **Entrevista motivacional (Miller y Rollnick)**: de elección ante **ambivalencia**; desarrollar la discrepancia; **OARS**: preguntas abiertas, afirmaciones, escucha reflexiva y resúmenes.
- Planes **"si-entonces"** (implementación de intenciones). **Demostración → práctica supervisada → retroalimentación** (insulina, inhaladores).
- **Grupal**: sesiones de **60-90 minutos**, exposición teórica máxima **15-20 minutos**; subgrupos de 3-5; lluvia de ideas; **role-playing** (actitudes y habilidades sociales: "ensayar decir no al alcohol"); estudios de caso; testimonios (aprendizaje vicario, centrados en el proceso); cierre en los últimos 5-10 minutos (**semáforo**, compromiso escrito).
- **Comunitaria**: ferias de salud, campañas, entornos (escuelas, trabajo), **teatro foro (Augusto Boal)**, **fotovoz** (técnica de **diagnóstico participativo**), mapeo comunitario, coaliciones, abogacía y agentes comunitarios.
- **Materiales escritos**: lenguaje sencillo, voz activa, **letra ≥ 12 puntos**, índices de legibilidad (**Flesch-Kincaid, SMOG**) y prueba piloto. **Vídeos de 5-10 minutos**. Se evalúan por comprensibilidad, aceptabilidad, viabilidad y efectividad.

A4. Autocuidado, cuidador y familia

- **Autocuidado**: acciones **deliberadas y por iniciativa propia** para mantener la vida y el bienestar. Áreas: automonitorización (AMPA, glucemia, **peso en IC**), síntomas de alarma, medicación, nutrición (etiquetas), actividad física (**escala de Borg**) y resolución de problemas.
- **Cuidador principal**: valorar necesidades y su propia salud; entrenamiento con simulación (demostración → práctica → verificación); signos de alarma; prevención de la **sobrecarga** (**Zarit**: sobrecarga a partir de 47 puntos), estrategias de respiro y **seguimiento telefónico tras el alta** (reduce reingresos).
- **Familia** (enfoque sistémico): **genograma** (estructura y relaciones internas), **ecomapa** (relación con **recursos externos**, redes de apoyo) y **Apgar familiar** (funcionalidad; **7-10 normofuncional**). Evitar los "pactos de silencio" y repartir las cargas.

Instrumentos de evaluación	Miden
ASA / ASA-R	Agencia de autocuidado (Orem)
Self-Care of Chronic Illness Inventory	**Mantenimiento, monitorización y manejo** (el más complejo)
EHFScBS	Autocuidado en **insuficiencia cardiaca**
Morisky-Green	Adherencia: 4 preguntas; un solo fallo = no cumplidor
Duke-UNC	**Apoyo social percibido** (confidencial y afectivo)
Escala de Gijón	Situación sociofamiliar del anciano
EuroQol-5D	Calidad de vida

- Adherencia: métodos subjetivos (autoinforme, Morisky-Green; sesgo de deseabilidad), objetivos indirectos (recuento de comprimidos, dispensación) y marcadores biológicos (HbA1c).

A5. Elaboración de programas de EpS

- **Análisis de necesidades**: indicadores (mortalidad, **AVPP**, morbilidad, factores de riesgo), demografía (pirámide), datos asistenciales (hospitalizaciones evitables) e información **cualitativa**; triangulación. Necesidades **sentidas** (comunidad) y **normativas** (expertos).
- **Priorización**: magnitud, gravedad, vulnerabilidad (¿es modificable?), trascendencia social y factibilidad. **Método Hanlon** (ver B4).
- **Objetivos**: de **impacto** (salud a largo plazo: infartos, mortalidad), de **resultado** (conductas, conocimientos), de **proceso** (actividades realizadas) y de **estructura** (recursos).
- **Cronograma**: **diagrama de Gantt** (tareas simultáneas, dependencias, ruta crítica). La **evaluación se diseña a la vez que la planificación** (ex ante), nunca al final.
- **Implementación**: formación de facilitadores, captación activa, **fidelidad** en los componentes esenciales y **adaptación** de los superficiales (idioma, horarios), coordinación intersectorial y registro.
- **Evaluación**: **proceso** (sesiones, asistencia, satisfacción), **resultado** (pre-post: conocimientos, conductas, HbA1c) e **impacto** (incidencia, mortalidad, calidad de vida). Diseños: ECA, cuasiexperimentales y **antes-después** (los más usados). Relevancia clínica además de $p < 0,05$.
- **Sostenibilidad**: financiación estable, **registro en la HCE** ("lo que no se registra no existe"), protocolización en GPC y apropiación comunitaria (*ownership*).

A6. Grupos de autoayuda y agentes de salud

- **Grupos de autoayuda**: voluntarios, **horizontales** (sin jerarquía), autogestionados, basados en la **reciprocidad** y en compartir un mismo problema. La enfermera es **facilitadora o asesora, nunca líder**. Riesgos: desinformación, liderazgos dominantes, dependencia de un líder.
- **Factores terapéuticos de Yalom**: **universalidad** ("no soy el único"), infusión de esperanza, **altruismo** ("ayudar me ayuda"), información compartida, catarsis y cohesión.
- Tipos: informales, estructurados, **federados** (Alcohólicos Anónimos); autónomos, **facilitados por profesionales** (lo más común en los centros de salud) o mixtos; presenciales o virtuales.
- **Agentes comunitarios de salud**: miembros de la comunidad elegidos por **arraigo, credibilidad y liderazgo** (no por titulación); hacen de puente cultural, **complementan y nunca sustituyen** al profesional. Prioridad formativa: **confidencialidad**. La enfermera es formadora y supervisora.
- Apoyo social: emocional, instrumental, informacional y evaluativo; efecto **directo** y **amortiguador** (*buffer*). **Prescripción social**: derivar a activos comunitarios.

BLOQUE B · Salud pública, indicadores y priorización

B1. Salud pública y niveles de prevención

Autor	Definición de salud pública
Winslow (1920)	Ciencia y arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y la **eficiencia física**; centrada en las **infecciosas**
Terris (1992)	Actualiza a Winslow: enfermedades en general (crónicas) y añade la **salud mental**
Piédrola Gil	Organizar los esfuerzos colectivos para proteger, promover y restaurar la salud

- **CE art. 43** (derecho a la protección de la salud) y art. 51 (consumidores). **Ley 33/2011**: salud pública como actividades organizadas por las Administraciones con participación de la sociedad; reconoce que la asistencia no es el principal determinante (**"salud en todas las políticas"**); derechos a la información, participación e igualdad.
- Murcia: **Ley 4/1994**; el **Plan de Salud** lo aprueba el Consejo de Gobierno; participación a través del **Consejo de Salud de la Región**.

Nivel (Leavell y Clark)	Fase	Objetivo
Primaria	Prepatogénica (promoción y protección: vacunas, cloración)	**Reduce la incidencia**
Secundaria	Subclínica: **cribados** (citología, mamografía, SOH)	**Reduce la prevalencia**
Terciaria	Enfermedad establecida: rehabilitación	Reduce secuelas e incapacidad
Cuaternaria (Jamoulle, 1986)	Evitar sobremedicalización (p. ej., **desprescribir benzodiacepinas**)	Reduce la **iatrogenia**

B2. Concepto de salud

Modelo	Autor	Clave
Holístico	**OMS (1946**, en vigor en 1948)	"Completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad". Críticas: **estática, utópica y subjetiva** (difícil de medir)
Dinámico	**Terris (1975)**	**Continuo salud-enfermedad** con zona neutra; elimina "completo"; aspecto subjetivo (bienestar) y objetivo (capacidad de funcionar)
Ecológico	**René Dubos (1959)**	**Adaptación** al medio; equilibrio agente-huésped-ambiente
Salutogénico	**Antonovsky (1979)**	Origen de la salud; **Sentido de Coherencia** y **activos para la salud** (no factores de riesgo)

B3. Indicadores de salud

- Propiedades: validez, fiabilidad, sensibilidad y especificidad.
- **Incidencia** (casos nuevos, mide **riesgo**): **acumulada** (proporción: casos nuevos / población en riesgo al inicio) y **densidad de incidencia** (tasa: casos nuevos / persona-tiempo; mide velocidad). **Prevalencia** (casos totales, mide **carga**; puntual o de periodo). **P = I × D**: un fármaco que alarga la vida sin curar **aumenta la prevalencia**.
- **Tasa bruta de mortalidad**: no sirve para comparar poblaciones con distinta estructura de edad → **tasa ajustada o estandarizada**. Tasa específica: por edad, sexo o causa.
- **Letalidad** = muertes por una enfermedad / **enfermos** de esa enfermedad × 100 (gravedad; rabia ≈ 99%). La mortalidad usa como denominador la **población total**.
- **Índice de Swaroop-Uemura**: % de defunciones de **≥ 50 años**; cuanto **más alto**, mejor nivel de salud.
- **AVAC (QALY)**: medida **positiva** (años × calidad 0-1). **AVAD (DALY)**: medida **negativa** (años perdidos por muerte prematura y discapacidad). **AVPP**: años potenciales perdidos por muerte prematura.
- **Esperanza de vida** al nacer; **esperanza de vida en buena salud** (libre de discapacidad).

Región de Murcia (según el manual)	
Esperanza de vida al nacer	83,3 años (mujeres 85,9; hombres 80,8)
Causas de muerte	1.ª **circulatorias (28%)**, 2.ª tumores (27%; **1.ª en hombres**), 3.ª respiratorias (10%)
Estratificación GMA	66% con al menos una enfermedad crónica; 4,2% crónicos complejos (15,4% en > 65 años)
Prevalencias (GMA)	HTA 20,1%, depresión 10,1%, diabetes 9,1%

B4. Problemas de salud y priorización

- **Transición demográfica** (baja natalidad, envejecimiento) y **epidemiológica de Omran** (predominio crónico). Pirámides: **pagoda o progresiva** (base ancha: alta natalidad y alta mortalidad, población joven), **campana o estacionaria** (estable) y **bulbo, urna o regresiva** (España y Murcia: natalidad bajo el reemplazo de **2,1 hijos por mujer**; prioridad: cronicidad, geriatría, paliativos).
- Cronicidad: Estrategia de Abordaje de la Cronicidad del SNS; estratificación GMA; paciente complejo "puerta giratoria". En Murcia: programa **Activa** (prescripción de ejercicio) y programa **Otago** (prevención de caídas, 65-80 años).

- **Emergentes** (aumento reciente o nuevos: SARS-CoV-2) y **reemergentes** (controladas que reaparecen: sarampión, tos ferina por bolsas de no vacunados). **Virus del Nilo Occidental**: zoonosis aves-humanos transmitida por mosquitos ***Culex*** (*C. pipiens*, *C. perexiguus*), sin vacuna humana.

Método Hanlon: (A + B) × C × D	
A · Magnitud	Escala 0-10 (personas afectadas)
B · Severidad o trascendencia	Mortalidad, discapacidad, coste, alarma social
C · Eficacia de la solución	**0,5 a 1,5** (baja 0,5, media 1, alta 1,5)
D · Factibilidad (PEARL o PERLA)	**Pertinencia, Economía, Aceptabilidad, Recursos y Legalidad**: cada uno **1 o 0**; **un solo 0 anula la prioridad**

- **CENDES/OPS**: magnitud, gravedad, vulnerabilidad y **coste**; enfoque economicista y rígido. **Parrilla de Simplex**: matriz gráfica de **eficacia (eje vertical)** y **factibilidad (eje horizontal)**: alta-alta = intervención prioritaria; baja-baja = descarte.

B5. Determinantes sociales y PBE

- **Lalonde (1974)**: biología humana, medio ambiente, **estilos de vida** y sistema sanitario. **Dever (1976)**, aplicándolo a la mortalidad: estilos de vida **43%** (el mayor), biología 27%, medio ambiente 19% y **sistema sanitario 11%**, que recibe en torno al **90% del gasto**.
- **Comisión de Determinantes Sociales de la OMS (Marmot, 2008)**: **estructurales** (contexto socioeconómico y político, gobernanza, posición social: educación, ocupación, renta, **género**, etnia) e **intermedios** (circunstancias materiales como la vivienda, factores conductuales y biológicos, psicosociales y el **propio sistema de salud**, que puede amortiguar o agravar).
- **Dahlgren y Whitehead (1991)**: "arcoíris" o capas de cebolla (ver tema 13). Salud comunitaria: **mapeo de activos**.
- **PBE (Sackett, 1996)**: uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia + experiencia del profesional + valores del paciente. Pasos: pregunta (**PICO**; **PIO** si no hay comparación, frecuente en comunitaria) → búsqueda (pirámide de evidencia) → lectura crítica (**CASPe**; **AGREE II** para GPC; **GRADE**, SIGN) → implementación → evaluación.
- **"Train the trainer"**: una enfermera referente se forma y difunde la evidencia al equipo de forma horizontal (efecto multiplicador). Sin evidencia de eficacia, el componente C de Hanlon no puede puntuar alto.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El teach-back evalúa la **claridad del profesional**, no la inteligencia del paciente.
! En un grupo de autoayuda la enfermera **facilita**, no dirige.
! Cribado = prevención **secundaria** (reduce prevalencia); desprescribir para evitar iatrogenia = **cuaternaria**.
! Componente C de Hanlon: **0,5-1,5**, nunca 0-10.
! Para comparar la mortalidad de dos regiones: tasa **ajustada**, no bruta.